



Fecha de Impresión: 07/09/2026 16:14
Centro de atención: Z01 - Zaragoza
Paciente: CC 1047417261 - OSVALDO JIMENEZ PEÑA
Fecha de Nacimiento: 23/04/1972
Religión:
Régimen: 2 - Subsidiado
Dirección: BARRIO BICENTENARIO M6 LT 28
Teléfono: 3054515862
Ocupación: 999: PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION
Grupo Poblacional:
Acompañante: ARMANDO ALTAMIRANDA
Teléfono Acomp.: 3004141103
Dirección Acomp.:
Responsable:
Teléfono Resp.:
Dirección Resp.:
Médico Tratante: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO
Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Atención: 14/10/2024 08:12
Admisión: AD1007396

Edad: 52 año(s), 5 mes(es) 21 día(s)
Creencia:
Nivel: 1

Lugar: Cartagena Bolívar

Raza:

Parentesco Acomp.:

Parentesco Resp.: AMIGO

Especialidad: MEDICINA INTERNA

Impreso por: AMIRANDA

Sexo: M
Estado Civil: Unión Libre

Carnet:

Etnia:

Tipo Vinculación:

EPICRISIS

DATOS DE LA CONSULTA

Historia Clínica: Registro clínico de urgencias
Fecha de Ingreso: 23/09/2024 15:57
Cama: 4-13
Motivo de la Consulta:
"NO COME, TIENE DOLOR EN LA PIERNA IZQUIERDA NO SE LA SIENTE"

ANTECEDENTES:

* 1-> ABSCESO EN MUSLO IZQUIERDO 2- MIASIS EN HERIDA+SIFILIS LATENTE +CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS +POLIO

* 2-> IDEM

* 5-> NIEGA

* 6->

Síntesis de la Enfermedad:

PACIENTE MASCULINO DE 52 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE MIASIS EN MUSLO DERECHO, SIFILIS LATENTE DE DURACION NO DETERMINADA, ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. DELIRIO ACTIVO QUIEN ACUDE POR FIEBRE CUADRO CLINICO DE VARIOS DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN FIEBRE NO CUANTIFICADA TOS INTERMITENTE, ASOCIADO A NAUSEAS Y EMESIS DE CONTENIDO GASTRICO

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomiélitis quién ingresó por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paradínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Dado cuadro respiratorio se solicitaron paradínicos infecciosos, con hallazgos de 2 de baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo, radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo, se solicitó TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidenció colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Valorado por nutrición quien indicó suplementación nutricional. Paciente a quien se le inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica (27/09/24) por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda y tercera dosis administrada el 04/10/24 y el 11/10/24 respectivamente, cumpliendo esquema. Cuenta con reporte de paradínicos control, que evidencian hemograma con anemia moderada microcítica, hipocrómica, sin criterios de transfusión, por elevada. Paciente valorado por trabajo social quienes confirmaron que paciente tiene domicilio establecido para cumplimiento de tratamiento RIPE. Al momento de la valoración, paciente hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotrofos con reducción en la movilidad, paciente en silla de ruedas, además se evidencia presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 2x2 cm no dolorosa a la palpación profunda, sin salida de secreción, no eritematosa, se revisa ionograma control con resolución de cuadro hidroelectrolítico, por lo que actualmente paciente sin criterios de manejo intrahospitalario por lo que se decide dar egreso médico, con manejo médico, cita control por infectología, se dan recomendaciones y signos de alarma para reconsultar. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Revisión Por Sistema:

SISTEMICO

EXAMEN FISICO:

Apariencia a su llegada:

PACIENTE QUIEN ACUDE POR SUS PROPIOS MEDIOS

Cabeza, cara y órganos de los sentidos:

NORMOCEFALO, ISOCORIAS REACTIVAS, ESCLERAS ANICTERICAS SIMETRIA FACIAL, FOSAS NASALES PERMEABLES, MUCOSAS SEMIHUMEDAS Y PALIDAS. CUELLO SIMETRICO SIN MASAS NI MEGALIAS NI ADENOPATIAS, NO INGURGITACION YUGULAR

Tórax:

SIMETRICO, EXPANSIBLE, SIN TIRAJES, MURMULLO VESICULAR UNIVERSAL SIN AGREGADOS, RUIDOS CARDÍACOS RITMICOS SIN SOPLOS.

Abdomen:

BLANDO, DEPRESIBLE, PERISTALSIS PRESENTE NO MASAS NI MEGALIAS NO DOLOR ABDOMINAL NO SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL. PUÑO PERCUSION LUMBAR NEGATIVA

Piel y faneras:

LESIONES MULTIPLES ANTIGUAS Y RECIENTES EN RODILLA IZQUIERDA LESION ULCEROSA O ESCARA EN SACRO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

Genito-Urinario:

NORMCONFIGURADO

Extremidades:

SIMÉTRICAS, EUTRÓFICAS, PULSOS PERIFÉRICOS PRESENTES, LLENADO CAPILAR MENOR DE 2 SEGUNDOS PACIENTE CON ATROFIA DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO LESIONES POR HERIDAS

Sistema nervioso central:

CONSCIENTE, ALERTA, ORIENTADO EN SUS TRES ESFERAS SIN DÉFICIT NEUROLÓGICO APARENTE. PARES CRANEALES CONSERVADOS, AUSENCIA DE SIGNOS MENINGEOS. FUERZA MUSCULAR DE DANIELS: E/5 SECUELAS DE POLIO. AUSENCIA DE SIGNOS CEREBELOSOS. GLASGOW COMA ESCALA: 15/15.

Análisis:

PACIENTE MASCULINO DE 52 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES DE MIASIS EN MUSLO DERECHO, SIFILIS LATENTE DE DURACIÓN NO DETERMINADA, ANTECEDENTE DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. DELIRIO ACTIVO QUIEN ACUDE POR FIEBRE CUADRO CLÍNICO DE VARIOS DÍAS DE EVOLUCIÓN CONSISTENTE EN FIEBRE NO CUANTIFICADA TOS INTERMITENTE, ASOCIADO A NAUSEAS Y EMESIS DE CONTENIDO GÁSTRICO PACIENTE SIN APARENTE FOCO SE ORDENAN PARACLÍNICOS

SSN 500CC A 60 CC POR HORA

PARACETAMOL AMP 1000MG IV AHORA

METOCLOPRAMIDA AMP 10 MG IV EN UNA HORA

HEMOGRAMA, PCR, BUN CREATININA, GLUCOSA, UROANÁLISIS

RADIOGRAFÍA DE TORAX

INFORMAR Y ANOTAR CAMBIOS

OBSERVACIÓN

DIAGNÓSTICOS DE ENTRADA:

Diagnóstico Principal: R509 : FIEBRE, NO ESPECIFICADA

Diagnóstico Relacionado 1: A530 : SIFILIS LATENTE, NO ESPECIFICADA COMO PRECOZ O TARDIA

EVOLUCIONES:

Fecha: 24/09/2024: 05:49:17, Historia: Notas de Urgencia, Prestador: FRANCIELENA MACIA CARABALLO, Especialidad: MEDICINA GENERAL

Asunto: EVOLUCIÓN MEDICINA GENERAL

Descripción: PACIENTE MASCULINO DE 52 AÑOS CON ANTECEDENTE DE ABSCESO EN MUSLO IZQUIERDO + SIFILIS LATENTE + CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS + POLIO, QUE INGRESA POR CUADRO CLÍNICO DE FIEBRE CUADRO CLÍNICO DE VARIOS DÍAS DE EVOLUCIÓN CONSISTENTE EN FIEBRE NO CUANTIFICADA TOS INTERMITENTE, ASOCIADO A NAUSEAS Y EMESIS DE CONTENIDO GÁSTRICO, SE TOMAN PARACLÍNICOS DE INGRESO CON CUADRO HEMÁTICO SIN LEUCOCITOSIS, ANEMIA, CON TROMBOCITOSIS, UROANÁLISIS NO PATOLÓGICO, SIN ELEVACIÓN DE AZOADOS, ELEVACIÓN DE REACTANTES DE FASE AGUDA CON RADIOGRAFÍA CON EVIDENCIA DE Opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho. Aparente imagen radiolúcida de pared gruesa en el ápice pulmonar izquierdo con diámetro mayor de 79 mm. TENIENDO EN CUENTA SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PULMONAR SE CONSIDERA SOLICITAR PARACLÍNICOS DE EXTENSIÓN Y VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNA SE EXPLICA AMPLIAMENTE PLAN DE MANEJO AL PACIENTE QUIEN REFIERE ENTENDER PLAN AISLAMIENTO RESPIRATORIO HASTA REPORTE DE BACILOSCOPIA USO DE TAPABOCA N95 OBLIGATORIO TAPON VENOSO NADA VIA ORAL HASTA REALIZACIÓN DE BACILOSCOPIAS, POSTERIORMENTE DIETA NORMAL PARACETAMOL 1000 MG IV CADA 8 HORAS SS/ TRANSAMINASAS, BILIRRUBINAS, GLUCOSA EN AYUNDO. SS/ BACILOSCOPIAS DE ESPUTO SERIADAS, PCR M TUBERCULOSIS, CULTIVO PARA M TUBERCULOSIS EN ESPUTO SS/ VALORACIÓN POR MEDICINA INTERNAS VYAC

Fecha: 25/09/2024: 13:20:54, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JORGE YEPES CARO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1

2. Secuelas motoras de Poliomiélitis

3. Anemia moderada microcítica hipocrómica

4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Refiere sentirse mejor del dolor en muslo izquierdo, sin dificultad respiratoria

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 110/70 mmHg, FC 105 lpm, FR 38 rpm, T 36.7°C, SpO2 98% a aire ambiente

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Piel normocrómica, masa blanda en muslo izquierdo en cara posterior.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, ictericia normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos. Se palpa aumento de volumen en cara posterior de muslo izquierdo aproximadamente 5 cm de diámetro, blando, doloroso a la palpación sin cambios inflamatorios locales de piel

Glasgow Coma Scale 15/15 (O4, V5, M6), consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 5/5 en extremidades superiores, 1/5 en miembros inferiores, sin signos de irritación meníngea, marcha no es posible

PARACLÍNICOS:

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

BACILOSCOPIA POSITIVO PARA BAAR(++)

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANALISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CELULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEINA C REACTIVA 10.4

Análisis:

Paciente masculino en la sexta década de la vida, habitante de calle, con secuelas motoras de polio en la infancia, en el 2021 con sífilis indeterminada tratada con una dosis de penicilina intrahospitalaria,

Ingresa en contexto de síntomas respiratorios crónicos, asociados a pérdida de peso, y malestar general, Se documenta en radiografía de tórax consolidaciones apicales y área cavitada apical derecha, con imagen de proyectil de bala en tórax. Pendiente tomografía de tórax para evaluar mejor parénquima.

Baciloscopia inicial positiva. Se documenta diagnóstico de tuberculosis pulmonar, y se iniciará manejo con terapia RIPE. Por áreas consolidativas se sospecha sobreinfección por lo que recibe antibióticoterapia.

Pendiente realización de ecografía de piel y tejidos blandos en miembro inferior izquierda en muslo proximal para esclarecer etiología de masa palpable.

Actualmente paciente clínicamente estable, con signos vitales dentro de parámetros normales, tolerando vía oral y oxígeno ambiente; cuenta con paraclínicos los cuales reportan VIH no reactivo, ionograma en parámetros normales, albumina fuera de rangos, vdr 1:4 diluciones.

Se solicita concepto de infectología para consideración de cicatriz serológica vs infección subtratada de sífilis indeterminada, que probablemente no completó tratamiento en 2021. Aunque cabe anotar que las diluciones iniciales eran 1/16 con descenso de las mismas en este momento

Pendiente valoración por psicología y trabajo social por difícil contexto psicosocial.

Debe continuar hospitalizado a espera de evolución y completar estudios diagnósticos. se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 26/09/2024: 09:47:05, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1

2. Secuelas motoras de Poliomieltis

3. Anemia moderada microcítica hipocrómica

4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere dolor en miembros inferiores. Afebril, sin deposiciones diarreicas ni episodios eméticos.

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 110/70 mmHg, FC 105 lpm, FR 38 rpm, T 36.7°C, SpO2 98% a aire ambiente

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

25/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR(++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR(++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

COLOR 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANALISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEINA C REACTIVA 10.4

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomieltitis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Al examen físico se valora paciente poco colaborativo, con movilidad de miembros inferiores limitada. Signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, apetito disminuido. A la espera de realización de tomografía de tórax, ecografía de piel y tejidos blandos de muslo proximal de miembro inferior izquierdo por sospecha de lesión abscedada, resto de paraclínicos y valoración por trabajo social. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 27/09/2024: 09:41:53, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1

2. Secuelas motoras de Poliomieltitis

3. Anemia moderada microcítica hipocrómica

4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere mejoría de cuadro respiratorio. Refiere 1 episodio febril el día de ayer.

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 110/70 mmHg, FC 105 lpm, FR 38 rpm, T 36.7°C, SpO2 98% a aire ambiente

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabellado normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpandible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

25/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR(++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR(++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomieltitis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Al examen físico se valora paciente poco colaborativo, con movilidad de miembros inferiores limitada. Signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, apetito disminuido. A la espera de reporte de tomografía de tórax, ecografía de piel y tejidos blandos de muslo proximal de miembro inferior izquierdo por sospecha de lesión abscedada, resto de paraclínicos y valoración por trabajo social. Se inicia manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 28/09/2024: 09:36:31, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1

2. Secuelas motoras de Poliomieltitis

3. Anemia moderada microcítica hipocrómica

4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

Subjetivo:

S: Paciente refiere mejoría de cuadro respiratorio.

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 110/70 mmHg, FC 105 lpm, FR 38 rpm, T 36.7°C, SpO2 98% a aire ambiente

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

25/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR(++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR(++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMAGENES

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se práctica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomiелitis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Al examen físico se valora paciente con movilidad de miembros inferiores reducida, con presencia de masa en muslo izquierdo, con reporte de ecografía positiva para colección de 12 cc. Signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, apetito disminuido. A la espera de reporte de tomografía de tórax, resto de paraclínicos y valoración por trabajo social. Se inicia manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 29/09/2024: 13:27:58, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: YOJANA PATRICIA PATIÑO JIMENEZ, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Sintomático respiratorio 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024) 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1 2. Secuelas motoras de Poliomiелitis 3. Anemia moderada microcítica hipocrómica 4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere mejoría de cuadro respiratorio.

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO: PA 110/70 mmHg, FC 105 lpm, FR 38 rpm, T 36.7°C, SpO2 98% a aire ambiente Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada. 25/09/24 BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR(++) BACILOSCOPIA #2 POSITIVO

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

PARA BAAR (++) 24/09/24 VIH 0.23 ALBÚMINA 1.7 CLORO 95 POTASIO 4.1 SODIO 133 VDRL 4 DILS 24/09/24 ALT 18 AST 18 BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30 23/09/24 HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000 UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS BUN 11, CREATININA 0.51 GLUCOSA 81 PROTEINA C REACTIVA 10.4 IMAGENES 27/09/24 ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN: Mediante ultrasonido de tiempo real se práctica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz). En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc. Planos musculares subyacentes de aspecto normal. CONCLUSIÓN: Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomiелitis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Al examen físico se valora paciente con movilidad de miembros inferiores reducida, con presencia de masa en muslo izquierdo, con reporte de ecografía positiva para colección de 12 cc. Signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, apetito disminuido. A la espera de reporte de tomografía de tórax, resto de paraclínicos y valoración por trabajo social. Se inicia manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 30/09/2024: 11:30:41, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1

2. Secuelas motoras de Poliomiелitis

3. Anemia moderada microcítica hipocrómica

4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere mejoría de cuadro respiratorio.

Objetivo:

EXAMEN FÍSICO:

PA 110/70 mmHg, FC 105 lpm, FR 38 rpm, T 36.7°C, SpO2 98% a aire ambiente

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

25/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEINA C REACTIVA 10.4

IMAGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos apices pulmonares y cavitación en apices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.
Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.
Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz). En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc. Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomieltis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Al examen físico se valora paciente con movilidad de miembros inferiores reducida, con presencia de masa en muslo izquierdo, con reporte de ecografía positiva para colección de 12 cc. Signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, apetito disminuido. A la espera de reporte de tomografía de tórax, resto de paraclínicos y valoración por trabajo social. Se inicia manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 01/10/2024: 12:54:07, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomieltis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere mejoría de cuadro respiratorio.

Objetivo:

TA 100/60 FC 104 T 37.7 FR 20 SAT 90%

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMAGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardíaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomielitis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Al examen físico se valora paciente con movilidad de miembros inferiores reducida, con presencia de masa en muslo izquierdo, con reporte de ecografía positiva para colección de 12 cc. Signos vitales en meta, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, apetito disminuido. Cuenta con reporte de baciloscopias positivas para BAAR. continuamos a la espera de resto de paraclínicos y valoración por trabajo social. Se inició manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 02/10/2024: 14:14:37, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1

2. Secuelas motoras de Poliomielitis

3. Anemia moderada microcítica hipocrómica

4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere mejoría de cuadro respiratorio.

Objetivo:

TA 113/68 MMHG FC 92 LPMFR 19 RPMT 35.9 °C SAT 93%

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES

BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMAGENES

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos apices pulmonares y cavitación en apices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomiелitis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Al examen físico se valora paciente con movilidad de miembros inferiores reducida, con presencia de masa en muslo izquierdo, con reporte de ecografía positiva para colección de 12 cc. Hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, con apetito disminuido. Se inició manejo con penicilina benzatinica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto. Cuenta con reporte de baciloscopias #1 y 2 positivas para BAAR. continuamos a la espera de resto de paraclínicos y valoración por trabajo social. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 03/10/2024: 11:52:50, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1

2. Secuelas motoras de Poliomiелitis

3. Anemia moderada microcítica hipocrómica

4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere estar tranquilo, mejoría de cuadro respiratorio.

Objetivo:

TA 113/68 MMHG FC 92 LPM FR 19 RPMT 35.9 °C SAT 93%

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES

BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

GLUCOSA81
PROTEINA C REACTIVA 10.4

IMAGENES
28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos apices pulmonares y cavitación en apices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRFIA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomieltis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Al examen físico se valora paciente con movilidad de miembros inferiores reducida, con presencia de masa en muslo izquierdo, con reporte de ecografía positiva para colección de 12 cc. Hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, con apetito disminuido. Se inició manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto. Cuenta con reporte de baciloscopias #1 y 2 positivas para BAAR. Continuamos a la espera de resultado de última baciloscopia, cultivo para M tuberculosis y valoración por trabajo social. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 04/10/2024: 11:23:31, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomieltis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere haber pasado buena noche, refiere persistencia de disminución de apetito.

Objetivo:

TA 110/70 MMHG FC 86 LPM FR 18 RPMT 36.0 °C SAT 97%

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

COLOR 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM65.2, HCM21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000
UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS
BUN 11, CREATININA 0.51
GLUCOSA 81
PROTEINA C REACTIVA 10.4

IMAGENES
28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:
Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.
No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.
El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos apices pulmonares y cavitación en apices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.
La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.
Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.
Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).
En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.
Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomiелitis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Al examen físico se valora paciente con movilidad de miembros inferiores reducida, con presencia de masa en muslo izquierdo, con reporte de ecografía positiva para colección de 12 cc. Hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, con apetito disminuido. Se inició manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, primera dosis 27/09/24, segunda dosis hoy 04/10/24. Cuenta con reporte de baciloscopias #1 y 2 positivas para BAAR. Continuamos a la espera de resultado de última baciloscopia, cultivo para M tuberculosis y valoración por trabajo social. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 05/10/2024: 09:38:57, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomiелitis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere haber pasado buena noche, con persistencia de disminución de apetito.

Objetivo:

TA 110/70 MMHG FC 98 LPM FR 20 RPM T 37.0 °C SAT 94%

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR(++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR(++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

COLOR 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

24/09/24
ALT 18 AST 18
BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24
HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000
UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS
BUN 11, CREATININA 0.51
GLUCOSA 81
PROTEINA C REACTIVA 10.4

IMAGENES
28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:
Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.
No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.
El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos apices pulmonares y cavitación en apices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.
La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.
Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.
Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24
ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:
Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).
En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.
Planos musculares subyacentes de aspecto normal.
CONCLUSIÓN:
Colección en muslo izquierdo.
Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomiелitis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Al examen físico se valora paciente con movilidad de miembros inferiores reducida, con presencia de masa en muslo izquierdo, con reporte de ecografía positiva para colección de 12 cc. Hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, con apetito disminuido. Se inició manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, primera dosis 27/09/24, segunda dosis el 04/10/24. Cuenta con reporte de baciloscopias #1 y 2 positivas para BAAR. Continuamos a la espera de resultado de última baciloscopia, cultivo para M tuberculosis y valoración por trabajo social. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 06/10/2024: 08:50:41, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomiелitis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

Subjetivo:

Paciente refiere persistencia de disminución de apetito.

Objetivo:

TA 116/79 MMHG FC 96 LPMFR 18 RPMT 37.1 °C SAT 96%

Luce en mal estado general, edad cronológica coherente con edad aparente, mal estado musculoesquelético.

Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado.

Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables.

Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso.

Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables.

Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo.

Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

24/09/24
BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)
BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24
VIH 0.23
ALBÚMINA 1.7

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

CLORO 95
POTASIO 4.1
SODIO 133
VDRL 4 DILS

24/09/24
ALT 18 AST 18
BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24
HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000
UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS
BUN 11, CREATININA 0.51
GLUCOSA 81
PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMAGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se práctica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomieltis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidencia colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotróficos con reducción en la movilidad, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, con apetito disminuido valorado por nutrición quien indicó que paciente requiere suplementación nutricional con el fin de cubrir los requerimientos de nutrientes. Paciente en quien el día 27/09/24 se inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda dosis administrada el día 04/10/24. Cuenta con reporte de baciloscopias #1 y 2 positivas para BAAR. Continuamos a la espera de valoración por trabajo social, cultivo para M tuberculosis. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 07/10/2024: 09:30:20, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomieltis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo
5. Desnutrición proteico-calórica moderada

Subjetivo:

Paciente refiere sentirse bien, refiere dolor en región inguinal, sin otra sintomatología asociada.

Objetivo:

TA 100/70 MMHG FC 100 LPM FR 18 RPMT 36.0 °C SAT 95%

Regular estado general, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, sin secreciones, no eritematosa. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR(++)
BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR(++)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

24/09/24
VIH 0.23
ALBÚMINA 1.7
CLORO 95
POTASIO 4.1
SODIO 133
VDRL 4 DILS

24/09/24
ALT 18 AST 18
BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24
HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000
UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS
BUN 11, CREATININA 0.51
GLUCOSA 81
PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMAGENES

28/09/24
TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:
Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:
Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.
No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.
El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.
La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.
Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.
Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24
ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:
Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).
En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.
Planos musculares subyacentes de aspecto normal.
CONCLUSIÓN:
Colección en muslo izquierdo.

Análisis:
Masculino de 52 años con antecedentes de poliomieltis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidencia colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotróficos con reducción en la movilidad, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, con apetito disminuido valorado por nutrición quien indicó que paciente requiere suplementación nutricional. Paciente en quien el día 27/09/24 se inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda dosis administrada el día 04/10/24. Cuenta con reporte de baciloscopias #1 y 2 positivas para BAAR. Continuamos a la espera de valoración por el servicio de trabajo social, y estudios solicitados. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 07/10/2024: 11:08:59, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomieltis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo
5. Desnutrición proteico-calórica moderada

Subjetivo:

Paciente refiere sentirse bien, refiere presencia de dolor en región inguinal, afebril, sin otra sintomatología asociada

Objetivo:

TA 99/70 MMHG FC 100 LPM FR 20 RPMT 35.8 °C SAT 97%
Regular estado general, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, sin secreciones, no eritematosa. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxica, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

24/09/24

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)
BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24
VIH 0.23
ALBÚMINA 1.7
CLORO 95
POTASIO 4.1
SODIO 133
VDRL 4 DILS

24/09/24
ALT 18 AST 18
BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24
HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000
UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS
BUN 11, CREATININA 0.51
GLUCOSA 81
PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMAGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomiелitis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidencia colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotrofos con reducción en la movilidad, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, con apetito disminuido valorado por nutrición quien indicó que paciente requiere suplementación nutricional. Paciente en quien el día 27/09/24 se inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda dosis administrada el día 04/10/24. Cuenta con reporte de baciloscopias #1 y 2 positivas para BAAR. Se solicitan paraclínicos control (hemograma - PCR - transaminasas) y con resultados definir nuevas conductas a seguir. Continuamos a la espera de valoración por el servicio de trabajo social. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 07/10/2024: 12:08:02, Historia: Notas, Prestador: ELIANA EDITH RAMOS MUÑOZ, Especialidad: TRABAJO SOCIAL

Asunto: SEGUIMIENTO POR TRABAJO SOCIAL

Descripción: Seguimiento desde el área de Trabajo Social con el objetivo de Brindar una atención integral y humanizada. Paciente masculino de 52 años de edad, en sala de hospitalización por diagnóstico que reposa en historia clínica, paciente que al momento del abordaje se encuentra sin acompañamiento familiar, refiere que su compañera sentimental, quien responde al nombre de Inasi, lo viene a visitar, pero que no había llegando el día de hoy. Se dedica a pedir plata en la calle, en el centro histórico de la ciudad, actualmente vive en el barrio la esperanza en una casa de un tíodo su mujer, es hijo único, tiene unos tíos y demás familiares que viven en el barrio Bicentenario, pero manifiesta que tiene muy poco apoyo por parte de ellos. Se brinda soporte al paciente para favorecer orientación y adaptación a la unidad, se promueve confianza en equipo asistencial.

Fecha: 08/10/2024: 09:35:01, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomiелitis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo
5. Desnutrición proteico-calórica moderada

Subjetivo:

S: Paciente refiere buena modulación del dolor inguinal, refiere pasar buena noche, sin otra sintomatología

Objetivo:

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

TA 100/70 MMHG FC 86 LPM FR 20 RPMT 36.4 °C SAT 97%

Regular estado general, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpandible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, sin secreciones, no eritematosa. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nomina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléjico, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

PARACLÍNICOS

7/10/24

LEU:10420 HB:9.5 HTO:30.9 VCM:69.6 PLAQ:581.000 PCR:10

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMÁGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardíaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS Blandos en Extremidad Inferior Izquierda (Muslo) + Portátil en Habitación:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomielititis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Debido a cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo. Además cuenta con radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho, y presencia de cuerpos extraños en ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo. Se solicitó además TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidencia colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotróficos con reducción en la movilidad, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, con apetito disminuido valorado por nutrición quien indicó que paciente requiere suplementación nutricional. Paciente en quien el día 27/09/24 se inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda dosis administrada el día 04/10/24. Cuenta con reporte de baciloscopias #1 y 2 positivas para BAAR. Cuenta con reporte de paraclínicos control, que evidencian hemograma con anemia moderada microcítica, hipocrómica, sin criterios de transfusión, pcr elevada. A la espera de realización de transaminasas por no disponibilidad de reactivos. Continuamos a la espera de valoración por el servicio de trabajo social. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 09/10/2024: 12:04:25, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomieltis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo
5. Desnutrición proteico-calórica moderada

Subjetivo:

Paciente refiere pasar buena noche, con buena modulación del dolor inguinal, sin otra sintomatología

Objetivo:

TA 100/70 MMHG FC 93 LPM FR 20 RPM T 36.2 °C SAT 94%

Regular estado general, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpandible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotrofos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, sin secreciones, no eritematosa. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómima y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorrefléxica, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

PARACLÍNICOS

7/10/24

LEU:10420 HB:9.5 HTO:30.9 VCM:69.6 PLQ:581.000 PCR:10

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMÁGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardíaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS Blandos en Extremidad Inferior Izquierda (Muslo) + Portátil en Habitación:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomieltis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada.

Se solicitan paraclínicos infecciosos dado cuadro respiratorio, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo, además de radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo, se solicitó TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidencia colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Valorado por nutrición quien indicó que paciente requiere suplementación nutricional. Paciente en quien el día 27/09/24 se inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda dosis administrada el día 04/10/24. Al momento de la valoración se evidencia paciente hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotrofos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 2x2cm levemente dolorosa a la palpación. Cuenta con reporte de paraclínicos control, que evidencian hemograma con anemia moderada

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

microcítica, hipocrómica, sin criterios de transfusión, pcr elevada. Paciente quien el día de hoy culmina cubrimiento antibiótico. Continuamos a la espera de transaminasas, valoración por el servicio de trabajo social. Se mantiene hospitalizado cumpliendo con terapia RIPE y a la espera de completar esquema con penicilina. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 10/10/2024: 11:01:41, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomieltis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo
5. Desnutrición proteico-calórica moderada

Subjetivo:

Paciente refiere modulación del dolor inguinal, refiere estar tranquilo, sin otra sintomatología.

Objetivo:

TA 110/70 MMHG FC 85 LPM FR 20 RPMT 34.8 °C SAT 97%

Regular estado general, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpandible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotroáficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm levemente dolorosa a la palpación, sin secreciones, no eritematosa. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómima y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

PARACLÍNICOS

7/10/24

LEU:10420 HB:9.5 HTO:30.9 VCM:69.6 PLAQ:581.000 PCR:10

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMÁGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardíaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS Blandos en EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomieltis quien ingresa por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Dado cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo, además de radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo, se solicitó TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidencia colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Valorado por nutrición quien indicó que paciente requiere suplementación nutricional. Cuenta con reporte de paraclínicos control, que evidencian hemograma con anemia moderada microcítica, hipocrómica, sin criterios de transfusión, pcr elevada. Paciente quien el día 27/09/24 se inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda dosis administrada el día 04/10/24. Al momento de la valoración se evidencia paciente hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotróficos con reducción en la movilidad, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 2x2cm levemente dolorosa a la palpación. Paciente quien continúa en estancia hospitalaria cumpliendo terapia RIPE y a la espera de culminación de esquema de manejo de sífilis. A la espera de transaminasas y valoración por el servicio de trabajo social. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 11/10/2024: 12:07:35, **Historia:** Evolución Clínica General, **Prestador:** ARIEL BELLO, **Especialidad:** MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomiélitis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo
5. Desnutrición proteico-calórica moderada

Subjetivo:

Paciente refiere sensación pulsátil en muslo izquierdo, con buena modulación del dolor inguinal, sin otra sintomatología

Objetivo:

TA 110/70 MMHG FC 117 LPM FR 19 RPMT 36.3 °C SAT 98%

Regular estado general, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, con escasa salida de secreción, no eritematosa. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómima y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

PARACLÍNICOS

7/10/24

LEU:10420 HB:9.5 HTO:30.9 VCM:69.6 PLAQ:581.000 PCR:10

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR(++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR(++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

COLOR 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

URONÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENERES, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES

BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMAGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardíaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS Blandos en EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomieltitis quien ingresó por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Dado cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo, además de radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo, se solicitó TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidenció colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Valorado por nutrición quien indicó suplementación nutricional. Cuenta con reporte de paraclínicos control, que evidencian hemograma con anemia moderada microcítica, hipocrómica, sin criterios de transfusión, por elevada. Paciente a quien se le inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica (27/09/24) por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda dosis administrada el día 04/10/24. Al momento de la valoración se evidencia paciente hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotróficos con reducción en la movilidad, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 2x2cm dolorosa a la palpación, con escasa salida de secreción. Paciente quien el día de hoy finaliza esquema de manejo de sífilis. En ronda médica paciente manifiesta sensación pulsátil y dolorosa en muslo izquierdo por lo que se ajusta manejo analgesico, además manifiesta tener lugar de vivienda sin hacinamiento para cumplir aislamiento respiratorio por patología de base, por lo que se decide solicitar valoración por trabajo social para definir egreso médico, se solicita además paraclínicos control. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 12/10/2024: 09:39:54, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: ARIEL BELLO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1

2. Secuelas motoras de Poliomieltitis

3. Anemia moderada microcítica hipocrómica

4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

5. Desnutrición proteico-calórica moderada

Subjetivo:

Paciente refiere pasar buena noche, sin dolor inguinal, sin sensación pulsátil en muslo izquierdo, sin otra sintomatología

Objetivo:

TA 110/80 MMHG FC 87 LPM FR 20 RPMT 35.6 °C SAT 98%

Regular estado general, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, con escasa salida de secreción, no eritematosa. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómima y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

PARACLÍNICOS

7/10/24

LEU:10420 HB:9.5 HTO:30.9 VCM:69.6 PLAQ:581.000 PCR:10

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR (++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR (++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES

BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

IMÁGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardíaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral,

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.
La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.
Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.
Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se practica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).
En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.
Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomiелitis quien ingresó por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Dado cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 de baciloscopias positivas para BAAR y VIH no reactivo, radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo, se solicitó TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidenció colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Valorado por nutrición quien indicó suplementación nutricional. Cuenta con reporte de paraclínicos control, que evidencian hemograma con anemia moderada microcítica, hipocrómica, sin criterios de transfusión, pcr elevada. Paciente a quien se le inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica (27/09/24) por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda dosis administrada el día 04/10/24 y tercera dosis administrada el día 11/10/24. Al momento de la valoración se evidencia paciente hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotróficos con reducción en la movilidad, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 2x2cm dolorosa a la palpación, con escasa salida de secreción. Cuenta con resultado de ionograma control que evidencia hipocloremia leve, hiponatremia leve, con función renal sin alteración, por lo que se decide indicar reposición e ionograma control para el día de mañana. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 13/10/2024: 09:58:11, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio
- 1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)
- 1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1
2. Secuelas motoras de Poliomiелitis
3. Anemia moderada microcítica hipocrómica
4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo
5. Desnutrición proteico-calórica moderada

Subjetivo:

Paciente refiere sentirse bien, pasar buena noche. Niega dolor, fiebre u otra sintomatología.

Objetivo:

TA 110/70 MMHG FC 76 LPM FR 20 RPMT 36.8 °C SAT 96%

Regular estado general, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpandible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 8x6cm dolorosa a la palpación, con escasa salida de secreción, no eritematosa. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómina y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

PARACLÍNICOS

7/10/24

LEU:10420 HB:9.5 HTO:30.9 VCM:69.6 PLAQ:581.000 PCR:10

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR(++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR(++)

24/09/24

VIH 0.23

ALBÚMINA 1.7

COLOR 95

POTASIO 4.1

SODIO 133

VDRL 4 DILS

24/09/24

ALT 18 AST 18

BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24

HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000

UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENERES, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES

BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS

BUN 11, CREATININA 0.51

GLUCOSA 81

PROTEÍNA C REACTIVA 10.4

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

IMAGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se práctica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomielitis quien ingresó por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Dado cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 de baciloscopias positivas para BAAR y VH no reactivo, radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo, se solicitó TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidenció colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Valorado por nutrición quien indicó suplementación nutricional. Cuenta con reporte de paraclínicos control, que evidencian hemograma con anemia moderada microcítica, hipocrómica, sin criterios de transfusión, pcr elevada. Paciente a quien se le inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica (27/09/24) por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda dosis administrada el día 04/10/24 y tercera dosis administrada el día 11/10/24. Al momento de la valoración se evidencia paciente hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotróficos con reducción en la movilidad, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 2x2cm dolorosa a la palpación, con escasa salida de secreción. Cuenta con resultado de ionograma control que evidencia hipocloremia leve, hiponatremia leve, con función renal sin alteración, por lo que se decide indicar reposición. De momento a la espera de resultado de ionograma control. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Fecha: 14/10/2024: 08:08:56, Historia: Evolución Clínica General, Prestador: JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO, Especialidad: MEDICINA INTERNA

Problema:

1. Sintomático respiratorio

1.1 Tuberculosis pulmonar confirmada microbiológicamente (25/09/2024)

1.2 Neumonía adquirida en la comunidad CURB-65 1

2. Secuelas motoras de Poliomielitis

3. Anemia moderada microcítica hipocrómica

4. Absceso de piel y tejidos blandos a descartar en muslo izquierdo

5. Desnutrición proteico-calórica moderada

Subjetivo:

Paciente refiere sentirse tranquilo, bien haber pasado buena noche. Niega dolor, picos febriles, episodios diarreicos

Objetivo:

TA 100/80 MMHG FC 100 LPM FR 20 RPM T 36.8 °C SAT 94%

Regular estado general, mal estado musculoesquelético. Cuero cabelludo normoimplantado, conjuntivas normocrómicas, isocoria normorreactiva, oculomotores normales, simetría facial, fosas nasales permeables, mucosa oral húmeda, orofaringe normal, dentadura en mal estado. Cuello simétrico, sin ingurgitación yugular, sin soplos carotídeos, móvil, sin masas ni adenopatías palpables. Tórax simétrico, normoexpansible, no tirajes, murmullo vesicular universal presente, sin sobreagregados, ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos, sin déficit de pulso. Abdomen plano, peristalsis (+), blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, sin signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Extremidades simétricas, miembros inferiores hipotróficos, sin edema, pulsos periféricos presentes, llenado capilar 2 segundos, presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 2x2cm no dolorosa a la palpación a la palpación profunda, sin salida de secreción, no eritematosa. Presencia de cuerpo extraño palpable (bala) en extremo proximal de miembro superior izquierdo. Glasgow Coma Scale 15/15, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, sensibilidad conservada, lenguaje fluido, nómima y repite, pares craneales sin déficit, fuerza muscular 1/5 en miembros inferiores, normorreflexo, sin signos de irritación meníngea, marcha no evaluada.

PARACLÍNICOS

13/10/2024

CI 100 K 4.2 MG 1.9 NA 136

11/10/24

BUN 12 CR 0.44

CL 95 K 4.7 MG 1.9 NA 130

7/10/24

LEU:10420 HB:9.5 HTO:30.9 VCM:69.6 PLAQ:581.000 PCR:10

24/09/24

BACILOSCOPIA #1 POSITIVO PARA BAAR(++)

BACILOSCOPIA #2 POSITIVO PARA BAAR(++)

24/09/24

VH 0.23

ALBÚMINA 1.7

CLORO 95

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

EPICRISIS

POTASIO 4.1
SODIO 133
VDRL 4 DILS

24/09/24
ALT 18 AST 18
BILIRRUBINAS TOTALES 0.53, BILIRRUBINA DIRECTA 0.23, BILIRRUBINA INDIRECTA 0.30

23/09/24
HEMOGRAMA: HB 9.7, VCM 65.2, HCM 21.1, HTO 29.8, LEUCOS 10700, NEUTRO 8740, LINFO 940, MONO 960, PLT 557000
UROANÁLISIS: AMARILLA, LIGITURBIO, SUIGENEREIS, DENSIDAD 101, PH 6, NITRITOS NEGATIVO, UROBILINOGENO NORMAL, CÉLULAS EPITELIALES BAJAS 0-2 XC, LEUCOCITOS 0-2 XC, BACTERIAS ESCASAS
BUN 11, CREATININA 0.51
GLUCOSA 81
PROTEINA C REACTIVA 10.4

IMAGENES

28/09/24

TAC TORAX SIMPLE Y CONTRASTADO:

Se obtienen registros para pulmón y mediastino, observando:

Estructuras vasculares mediastinales de curso y calibre normales. Silueta cardiaca sin evidencia de alteraciones.

No se determinan adenopatías mediastinales o hiliares.

El parénquima pulmonar presenta imagen de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ápices pulmonares de manera bilateral, hay opacidades reticulonodulares distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio crónico de origen granulomatoso.

La vascularización pulmonar no presenta alteraciones.

Las estructuras óseas tienen apariencia normal para la edad.

Tejidos blandos de la pared torácica y axilas libres.

27/09/24

ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA (MUSLO) + PORTÁTIL EN HABITACIÓN:

Mediante ultrasonido de tiempo real se práctica exploración de los tejidos blandos de las extremidades inferiores con transductor de alta frecuencia (9MHz).

En tejido celular subcutáneo de aspecto medial de muslo izquierdo se observa colección particulada y con presencia de gas, con volumen aproximado de 12 cc.

Planos musculares subyacentes de aspecto normal.

CONCLUSIÓN:

Colección en muslo izquierdo.

Análisis:

Masculino de 52 años con antecedentes de poliomiелitis quien ingresó por tos con expectoración, dificultad respiratoria y fiebre. Paraclínicos de ingreso con evidencia de anemia moderada y trombocitosis, uroanálisis no patológico, función renal conservada. Dado cuadro respiratorio se solicitaron paraclínicos infecciosos, con hallazgos de 2 de baciloscopias positivas para BAAR y VH no reactivo, radiografía de tórax con reporte de opacidades intersticiales reticulares especialmente en el ápice pulmonar derecho y tejidos blandos de brazo izquierdo, se solicitó TAC de tórax, con reporte de dilataciones bronquiales en ambos ápices pulmonares y cavitación en ambos ápices pulmonares, y opacidades distribuidas de manera aleatoria por proceso inflamatorio granulomatoso. Cuenta con reporte de ecografía de tejidos blandos en extremidad inferior izquierda que evidenció colección particulada y con presencia de gas de volumen aproximado de 12 cc. Valorado por nutrición quien indicó suplementación nutricional. Paciente a quien se le inició primera dosis de manejo con penicilina benzatínica (27/09/24) por antecedente de sífilis en 2021 con tratamiento incompleto, segunda y tercera dosis administrada el 04/10/24 y el 11/10/24 respectivamente, cumpliendo esquema. Cuenta con reporte de paraclínicos control, que evidencian hemograma con anemia moderada microcítica, hipocrómica, sin criterios de transfusión, pcr elevada. Paciente valorado por trabajo social quienes confirmaron que paciente tiene domicilio establecido para cumplimiento de tratamiento RIPE. Al momento de la valoración, paciente hemodinámicamente estable, tolerando oxígeno ambiente y vía oral, al examen físico se evidencia miembros inferiores hipotróficos con reducción en la movilidad, paciente en silla de ruedas, además se evidencia presencia de masa blanda en muslo izquierdo y cara posterior de 2x2 cm no dolorosa a la palpación profunda, sin salida de secreción, no eritematosa, se revisa ionograma control con resolución de cuadro hidroelectrolítico, por lo que actualmente paciente sin criterios de manejo intrahospitalario por lo que se decide dar egreso médico, con manejo médico, cita control por infectología, se dan recomendaciones y signos de alarma para reconsultar. Se explica a paciente quien refiere entender y aceptar.

Procedimientos Realizados y Ordenados:

Medicamentos Ordenados y Administrados:

Medidas Generales Ordenadas:

Justificación de indicaciones Terapéuticas:

Complicaciones:

NINGUNA

Servicio de Egreso: 000014|Hospitalización 4to Piso

Fecha de Egreso: 14/10/2024 08:12

Motivo de Salida: Alta

Estado a la Salida: Vivo

DIAGNÓSTICOS DE SALIDA:

Diagnóstico Principal: A150 : TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA POR HALLAZGO MICROSCOPICO DEL BACILO TUBERCULOSO EN ESPUTO, CON O SIN CULTIVO

Diagnóstico Relacionado 1: R509 : FIEBRE, NO ESPECIFICADA

PLAN ATENCIÓN INTEGRAL POR MEDICINA:

Tratamiento Farmacológico:

FORMULACION MEDICA AMBULATORIA:

TERAPIA RIPE - RIFAMPICINA 150 MG + ISONIAZIDA 75 MG + PIRAZINAMIDA 400 MG + ETAMBUTOL 275 MG TABLETA, ADMINISTRAR 3 TABLETAS VO CADA DIA

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Impresión: 07/09/2026 4:12:42 p. m.

Admisión: AD1007396

Administradora: COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A

Paciente: OSVALDO JIMENEZ PEÑA

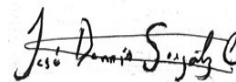
EPICRISIS

(FI: 25/09/2024) POR 56 DOSIS 6 DIAS A LA SEMANA, DESACANSA LOS DOMINGOS D16/56. #120 TABLETAS POR 40 DIAS
PIRIDOXINA 50MG VO CADA DIA POR 30 DÍAS #30 TABLETAS

Recomendaciones Adicionales:

CITA CONTROL POR INFECTOLOGÍA

Aplica Cuidados de Enfermería: No



JOSE DENNIS GONZALEZ CASTRO
MEDICINA INTERNA

CC:73139025 - RM.CC:73139025 - RM:1463